

MẪU ĐĂNG KÝ THUỐC: TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (1/2)

Acetylcystein 200mg

Cốm pha hỗn dịch

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.

1. Thành phần công thức thuốc

Mỗi gói chứa:

- Thành phần được chất: Acetylcystein.....200 mg
- Thành phần tá dược: Lactose monohydrat, aspartam, màu vàng sunset, bột hương cam vừa đủ 1 gói.

2. Dạng bào chế

- Dạng bào chế: Cốm pha hỗn dịch.
- Mô tả sản phẩm: Cốm màu vàng cam, vị chua ngọt, mùi hương cam.

3. Chỉ định

Hỗ trợ điều trị tiêu chất nhầy trong các trường hợp tăng tiết đờm nhầy quánh ở đường hô hấp.

4. Liều dùng, cách dùng

- Liều dùng:

- Người lớn và trẻ trên 7 tuổi: Uống 1 gói x 3 lần/ngày;
 - Trẻ từ 2 đến 7 tuổi: Uống 1 gói x 2 lần/ngày.
 - Dự phòng giảm chức năng thận do thuốc cản quang: Uống 3 gói x 2 lần/ngày. Dùng trong 2 ngày (Bắt đầu dùng 1 ngày trước và trong ngày dùng thuốc cản quang), tổng cộng 4 liều.
- Cách dùng: Hòa lượng thuốc trong gói vào nước để uống. Ảnh hưởng của thức ăn đến sự hấp thu acetylcystein chưa rõ, do đó không có khuyến cáo cụ thể uống thuốc trước hoặc sau bữa ăn.

5. Chống chỉ định

- Quá mẫn với acetylcystein hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Trẻ sơ sinh (dưới 2 tuổi).

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

- Không nên sử dụng kết hợp với các thuốc giảm ho, vì có thể gây tắc nghẽn chất nhầy, tăng nguy cơ co thắt phế quản và nhiễm trùng đường hô hấp.
- Thận trọng khi sử dụng acetylcystein ở người có nguy cơ xuất huyết tiêu hóa (loét dạ dày tiềm ẩn hoặc giãn thực quản) vì có thể gây nôn.
- Do tăng nguy cơ co thắt phế quản, cần thận trọng theo dõi chặt chẽ quá trình điều trị acetylcystein ở bệnh nhân bị hen phế quản và tăng phản ứng phế quản hệ thống. Nếu cơn co thắt phế quản xảy ra, ngưng sử dụng acetylcystein ngay và điều trị y tế thích hợp bằng cách dùng thuốc phun mù giãn phế quản nhóm beta 2-adrenergic chọn lọc, tác dụng ngắn (salbutamol) hoặc nhóm kháng muscarin (ipratropium).
- Khi sử dụng acetylcystein, đặc biệt lúc bắt đầu điều trị, thuốc có thể làm lỏng và tăng khối lượng dịch tiết phế quản. Nếu bệnh nhân không có đủ phản xạ ho, nên có biện pháp thích hợp để loại bỏ dịch tiết (dẫn lưu và hút dịch).
- Acetylcystein có thể ức chế *in vitro* 20 – 50% diamin oxidase (DAO). Do đó thận trọng khi sử dụng acetylcystein ở người không dung nạp histamin.
- Thuốc tiêu đờm có thể gây khó thở ở trẻ sơ sinh (dưới 2 tuổi). Do đặc điểm sinh lý hô hấp ở trẻ sơ sinh, khả năng tự làm sạch dịch nhầy phế quản bị hạn chế. Vì vậy chống chỉ định dùng acetylcystein cho trẻ sơ sinh.
- Thuốc có chứa lactose, do đó chống chỉ định với người mắc rối loạn di truyền hiếm gặp liên quan đến không dung nạp lactose hoặc hội chứng kém hấp thu glucose và galactose.
- Thuốc có chứa aspartam, do đó chống chỉ định với bệnh nhân mắc rối loạn phenylketo niệu.
- Thuốc có chứa tá dược màu vàng sunset, do đó có thể gây phản ứng quá mẫn.

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

- Phụ nữ có thai: Dữ liệu nghiên cứu về việc sử dụng acetylcystein ở một số phụ nữ có thai cho thấy không có tác dụng phụ đối với người mẹ hoặc sức khỏe của thai nhi. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy không có ảnh hưởng có hại trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến độc tính sinh sản. Vì vậy phụ nữ có thai nên thận trọng khi sử dụng acetylcystein.
- Phụ nữ cho con bú: Không có đủ thông tin về sự bài tiết acetylcystein vào sữa mẹ. Do đó nguy cơ cho trẻ bú mẹ không được loại trừ. Vì vậy không nên sử dụng acetylcystein trong thời kỳ cho con bú, trừ khi thật cần thiết sau khi đã đánh giá lợi ích và nguy cơ.

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

9. Tương tác, tương kỵ của thuốc

- Sử dụng đồng thời acetylcystein với than hoạt tính có thể làm giảm tác dụng của acetylcystein.
- Thử nghiệm *in vitro* cho thấy acetylcystein ức chế tác dụng của kháng sinh khi trộn chung với nhau. Vì vậy nên thận trọng dùng kháng sinh đường uống cách xa acetylcystein ít nhất 2 giờ.
- Sử dụng đồng thời acetylcystein và glyceryl trinitrat có thể gây giãn mạch và tăng ức chế kết tập tiểu cầu.
- Sử dụng đồng thời acetylcystein và carbamazepin có thể làm giảm nồng độ carbamazepin dưới nồng độ điều trị.
- Sử dụng đồng thời acetylcystein với thuốc giảm ho là không hợp lý (xem mục 6).
- Tương kỵ: Acetylcystein phản ứng với một số kim loại như sắt, niken, đồng và với cao su. Cần tránh thuốc tiếp xúc với các chất đó.

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc

Bảng tóm tắt các phản ứng có hại: được phân nhóm theo tần suất: rất thường gặp (ADR $\geq$ 1/10), thường gặp (1/100 $\leq$ ADR < 1/10), ít gặp (1/1000 $\leq$ ADR < 1/100), hiếm gặp (1/1000 $\leq$ ADR < 1/10000) và rất hiếm gặp (ADR < 1/10000).



MẪU ĐĂNG KÝ THUỐC: TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (2/2)

Hệ cơ quan	Tần suất phản ứng có hại			
	Ít gặp	Hiếm gặp	Rất hiếm gặp	Không xác định
Rối loạn miễn dịch	Quá mẫn		Sốc phản vệ	
Rối loạn hệ thần kinh	Đau đầu			
Rối loạn thính giác	Ù tai			
Rối loạn tim	Nhịp tim nhanh			
Rối loạn mạch	Hạ huyết áp		Xuất huyết	
Rối loạn hô hấp, lồng ngực, trung thất		Co thắt phế quản		
Rối loạn hệ tiêu hóa	Nôn, tiêu chảy, viêm miệng, đau bụng, buồn nôn	Khó tiêu		
Rối loạn da và các phản phụ	Mề đay, ban đỏ, phù mạch, ngứa			
Rối loạn chung và các tình trạng khác	Sốt			Phù mắt
Báo cáo điều tra	Giảm huyết áp			

Quá mẫn có thể xảy ra ở dạng phản ứng da và co thắt phế quản ở bệnh nhân bị hen phế quản và tăng phản ứng phế quản hệ thống.

Phản ứng có hại trên da như hội chứng Steven-Johnson và hoại tử biểu bì độc đã được báo cáo khi sử dụng với acetylcystein. Hầu hết các trường hợp này sử dụng acetylcystein cùng lúc với ít nhất một thuốc khác, có thể là do làm tăng mức phản ứng trên niêm mạc. Trường hợp tái phát tổn thương da và niêm mạc, nên ngưng sử dụng acetylcystein ngay và liên hệ y tế.

Sự giảm kết tập tiểu cầu khi sử dụng với acetylcystein đã được xác nhận trong nhiều nghiên cứu. Các vấn đề liên quan lâm sàng đến nay chưa được làm rõ.

11. Quá liều và cách xử trí

- **Dấu hiệu và triệu chứng:** Nghiên cứu trên tình nguyện viên khỏe mạnh cho thấy khi sử dụng acetylcystein liều 11,2 g/ngày trong 3 tháng chưa xảy ra phản ứng có hại nghiêm trọng nào. Liều uống 500 mg/kg thể trọng cho thấy cơ thể vẫn dung nạp mà chưa biểu hiện độc tính. Tuy nhiên nếu quá liều acetylcystein cấp tính xảy ra, có thể gây ra các triệu chứng tiêu hóa như buồn nôn, nôn và tiêu chảy.

- **Cách xử trí:** Điều trị triệu chứng và hỗ trợ theo chỉ định của bác sĩ dựa trên tình trạng lâm sàng của bệnh nhân.

12. Đặc tính dược lực học, dược động học

Đặc tính dược lực học

Nhóm dược lý: Thuốc tiêu nhầy.

Mã ATC: R05CB01

Acetylcystein có tác dụng tiêu nhầy bằng cách phân giải các liên kết disulfid trong glycoprotein của chất nhầy. Ngoài ra acetylcystein còn có tác dụng chống oxy hóa trực tiếp các gốc oxy hóa ưa điện tử. Acetylcystein cũng cung cấp tiền chất cystein cần thiết cho tổng hợp glutathion, làm tăng nguồn glutathion nội sinh. Các gốc oxy hóa nội sinh và ngoại sinh tham gia vào quá trình gây bệnh viêm đường hô hấp này sẽ bị trung hòa bởi acetylcystein và glutathion.

Đặc tính dược động học

Hấp thu

Acetylcystein sau khi uống được hấp thu nhanh chóng. Do chuyển hóa lần đầu qua gan, sinh khả dụng của acetylcystein còn khoảng 10%. Sau khi dùng liều acetylcystein 30 mg/kg cân nặng, nồng độ acetylcystein tổng (dạng tự do và liên kết) đạt tối đa trong huyết tương là 67 nmol/ml, với t_{max} = 0,75 - 1 giờ.

Phân bố

Acetylcystein phân bố trong cơ thể ở dạng không đổi, dạng dẫn xuất oxy hóa tự do và liên kết thuận nghịch với protein huyết tương. Acetylcystein phân bố chủ yếu trong gan, thận, phổi và dịch nhầy phế quản. Thể tích phân bố 0,47 lít/kg, tỷ lệ gắn kết protein huyết tương là 83%.

Chuyển hóa

Acetylcystein khi chuyển hóa qua thành ruột và chuyển hóa lần đầu ở gan sẽ được khử thành cystein, sau đó chuyển hóa thành các dạng liên kết không hoạt động khác.

Thải trừ

Khoảng 30% liều dùng được thải trừ trực tiếp qua thận, gồm các chất chuyển hóa chính là cystein và cystin. Ngoài ra còn có một lượng nhỏ taurin và sulfat được bài tiết.

13. Quy cách đóng gói

Hộp 30 gói.

14. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc

- **Điều kiện bảo quản:** Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

- **Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

- **Tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:** TCCS.

15. Cơ sở sản xuất



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25

448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM, VIỆT NAM

ĐT: (84.28) 39.414.968

FAX: (84.28) 39.415.550

